

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO PERTURBADOR (DBD)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Criterial DSM-5 de TDAH, Negativismo Desafiante y Trastorno de Conducta

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Trastornos de Comportamiento Perturbador (DBD Rating Scale).
Nombre Original (Inglés)	<i>Disruptive Behavior Disorders Rating Scale (DBD)</i>
Autores Originales	William E. Pelham Jr., Elizabeth M. Gnagy, Kirsten E. Greenslade y Michael D. Fabiano (1992); Barkley (1997).
Adaptaciones Españolas	Farré-Riba y Narbona (1997, Revista de Neurología); Servera y Cardo (2007).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Heteroinforme para padres y profesores de patología externalizante.
Tipo de Instrumento	Escala conductual de 45 reactivos politómicos de 4 opciones (0 = Nada a 3 = Mucho) alineada con criterios DSM.
Población y Rango	Niños y adolescentes de 5 a 18 años. Evaluados mediante informantes clave (padres, tutores y docentes).
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos por informante.
Régimen de Licencia	Dominio público para uso clínico, escolar y de investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO EXTERNALIZANTE

La escala DBD fue formulada por Pelham y colaboradores (1992) con el propósito de operacionalizar con rigor psicométrico el espectro de los **Trastornos del Comportamiento Perturbador** en la infancia. El instrumento traduce de manera directa y literal los criterios sintomáticos del DSM para facilitar el diagnóstico diferencial entre las entidades externalizantes más prevalentes.

Desde la perspectiva neurobiológica y del desarrollo, la escala permite deslindar dos componentes psicopatológicos cardinales: por un lado, las disfunciones en las funciones ejecutivas y el control inhibitorio frontoestriatal (TDAH inatento e hiperactivo-impulsivo); por otro lado, las alteraciones en el procesamiento socioemocional, la frustración y la empatía (Trastorno Negativista Desafiante y Trastorno de Conducta Disocial). La administración paralela a padres y profesores resulta esencial para verificar el criterio de ubicuidad transituacional.

3. SUBESCALAS DIAGNÓSTICAS DE LA DBD (CRITERIOS DSM)

Subescala Diagnóstica	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Clínica
1. TDAH — Inatención	1 al 9	0 a 27	Errores por descuido, desorganización, distracción fácil, olvidos cotidianos y pérdida de objetos.
2. TDAH — Hiperactividad	10 al 18	0 a 27	Inquietud motora, levantarse del asiento, correteo excesivo, habla verborreica e impulsividad verbal.
3. Negativismo Desafiante	19 al 26	0 a 24	Accesos de cólera, discusión con adultos, desafío activo de normas, susceptibilidad y rencor.
4. Trastorno de Conducta	27 al 42	0 a 48	Agresiones físicas, peleas, uso de armas, crueldad con animales, robos, mentiras y destrucción de bienes.
TOTAL COMBINADO	1 al 45	0 a 135	Índice multidimensional acumulativo de gravedad psicopatológica externalizante.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: coeficientes alfa de Cronbach de 0.89 a 0.94 en muestras españolas escolares y clínicas de neuropsiquiatría (Farré-Riba y Narbona, 1997; Servera y Cardo, 2007).
Fiabilidad Interjueces	Correlación moderada a alta entre padres y profesores ($r = 0.56$ a 0.68), concordante con los estándares de evaluación multimétodo y multi-informante infanto-juvenil.
Validez de Criterio	Sensibilidad diagnóstica $> 88\%$ y especificidad $> 85\%$ para clasificar subtipos de TDAH y TND confirmados mediante entrevistas diagnósticas estructuradas (DICA/DISC).
Validez Discriminante	Distingue claramente entre el TDAH primario puro y los trastornos comórbidos del comportamiento perturbador o dificultades específicas del aprendizaje.
Sensibilidad Terapéutica	Demuestra gran reactividad y sensibilidad al cambio en monitorizaciones de respuesta a psicoestimulantes (metilfenidato, lisdexanfetamina) y entrenamiento a padres.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CRITERIOS DSM

Cada conducta observada se valora en una escala politómica de 4 alternativas:

- **0** = Nada / Nunca | **1** = Un poco / Rara vez | **2** = Bastante / A menudo | **3** = Mucho / Casi siempre.
- **Método Cuantitativo Dimensional:** Se calcula la puntuación sumatoria de cada subescala (Inatención 0–27, Hiperactividad 0–27, TND 0–24, TC 0–48) para contrastar con tablas de baremos normativos por percentiles.
- **Método Categorical Criterial DSM:** Un síntoma se computa como **positivamente presente** si el informante marca **2 (“Bastante”)** o **3 (“Mucho”)**. Se comprueba el cumplimiento de umbrales:

Inatención: ≥ 6 de 9 | Hiperactividad: ≥ 6 de 9 | TND: ≥ 4 de 8 | TC: ≥ 3 de 16

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (FARRÉ-RIBA & NARBONA, 1997)

Percentil	Rango Dir.	Interpretación Clínica	Conducta Asistencial Recomendada
< P75	Bajo/ Medio	Conducta dentro de la norma evolutiva	Ausencia de sintomatología clínica disruptiva relevante. Manejo psicoeducativo general.
P75 – P89	Elevado	Zona de riesgo / Sintomatología subclínica	Conductas disruptivas frecuentes. Seguimiento pedagógico y pautas básicas de manejo contingencial.
P90 – P94	Muy elevado	Corte Clínico Significativo	Alta probabilidad de trastorno formal. Evaluación neuropsicológica y valoración en salud mental infantil.
$\geq$ P95	Severo	Patología Grave / Disfunción Severa	Severa interferencia académica, familiar y social. Abordaje multimodal intensivo urgente.

REQUISITO DE MULTI-INFORMANTE Y UBICUIDAD: Para el diagnóstico de TDAH, el DSM exige que los síntomas se manifiesten en **dos o más contextos** (hogar y escuela). Una elevación en la versión de profesores no refrendada por padres suele indicar dificultades específicas de aprendizaje, problemas relacionales en el aula o desmotivación pedagógica, más que un TDAH primario.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ÁRBOL DE DECISIÓN DIAGNÓSTICA MULTIMODAL:

- **Paso 1 (TDAH):** Verificar si cumple *ge6* síntomas en Inatención y/o Hiperactividad en padres Y profesores. Si se confirma, clasificar subtipo: Inatento Puro, Hiperactivo-Impulsivo o Combinado.
- **Paso 2 (Comorbilidad Oposicionista):** Evaluar subescala TND. Si *ge4* síntomas positivos, diagnosticar comorbilidad TDAH + TND; priorizar entrenamiento conductual para padres (Parent Management Training).
- **Paso 3 (Descarte de Trastorno Disocial):** Si aparecen reactivos de TC (agresiones, robos, crueldad), valorar derivación a servicios sociales y programas comunitarios de conducta.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ESCOLAR DE 9 AÑOS

Paciente: Niño de 9 años, derivado por el colegio debido a dificultades continuas para terminar las tareas, interrupciones sistemáticas en clase, discusiones agresivas con docentes y constantes quejas de los compañeros por juegos bruscos.

Resultados DBD (Padres y Profesores):

- **Profesores:** Inatención = 22/27 (8 ítems *ge2*, > P95); Hiperactividad = 21/27 (7 ítems *ge2*, > P95); TND = 18/24 (6 ítems *ge2*, > P90); Trastorno de Conducta = 3/48 (< P70).
- **Padres:** Inatención = 19/27 (7 ítems *ge2*, > P90); Hiperactividad = 20/27 (7 ítems *ge2*, > P90); TND = 15/24 (5 ítems *ge2*, > P85); Trastorno de Conducta = 1/48 (< P50).

Conducta Asistencial: Se confirma diagnóstico de TDAH Combinado comórbido con Trastorno Negativista Desafiante. Se prescribe tratamiento farmacológico con metilfenidato de liberación prolongada y se inicia entrenamiento a padres en economía de fichas y límites contingentes, en coordinación con adecuaciones metodológicas en el aula escolar. A los 3 meses, las puntuaciones DBD en el colegio descendieron al rango P65 en ambas subescalas, normalizando la convivencia escolar.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: VIOLENCIA Y RIESGO FÍSICO

Cualquier puntuación positiva en ítems de agresión física hacia personas/animales o destrucción de propiedad exige activación de protocolos de protección a la infancia y evaluación de riesgo forense.

DESCARTE DE TRAUMA Y MALTRATO

En niños con desregulación conductual severa y oposicionismo masivo, debe explorarse la presencia de dinámicas de maltrato intrafamiliar, negligencia o estrés postraumático complejo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Pelham, W. E., Gnagy, E. M., Greenslade, K. E., & Fabiano, M. D. (1992). Teacher ratings of DSM-III-R symptoms for the disruptive behavior disorders. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 31(2), 210–218.
2. Farré-Riba, A., & Narbona, J. (1997). Escalas de Conners en la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad: nuevo estudio factorial y de reproducibilidad. *Revista de Neurología*, 25(138), 200–204.
3. Servera, M., & Cardo, E. (2007). Children Disruptive Behavior Scale (EDAH): psychometric properties and norms for the Spanish population. *Psicothema*, 19(3), 403–409.
4. Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, 121(1), 65–94.